



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : ماجده احمد السيد حسنين
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : المطرية
رقم البطاقة : 26205190100129 رقم التليفون : 01148023061
العمر (تاريخ الميلاد) : 19-05-1962 المهنة : بدون عمل
العنوان : 29 ش جمعة عظيم- دار السلام البساتين
تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
قسم العلاج : الاورام
[11129]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ماجده احمد السيد حسني National ID: 26205190100129	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



١٠٨٥
ايجات وصاليل
سونار بفرن و صوهر
سونار شى





Women's Health Outreach Program

Name; magda ahmed

Date: 29/3/2020

Contrast Enhanced Spectral Mammography:

Clinical summary:

left breast proved malignancy

Findings:

Dispersed fibroglandular densities (ACR b)

After Contrast administration:

- Minimal background parenchymal enhancement.
- left breast central lesion with heterogeneous mass enhancement with spiculated margins, measuring 1.8 in diameter at middle one third of the breast. The lesion is seen 6.5 cm from the nipple.
- No right enhancing lesions

Conclusion: (BIRADS c)

Left unifocal malignancy

No right malignancy detected

Best Regards
Dr. Lamia Adel MD

58 g.c
ex. 11

4 cm (older 36)
No right breast mass

Name: ماجده احمد السيد حسنين		
MR. : 2896		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient is a 64-year-old individual with a history of diabetes mellitus and hypertension who underwent upfront breast conserving surgery in 2020 for a stage I (pT1N0) disease. Post-operative management included adjuvant chemotherapy with anthracyclines and taxanes, followed by radiation therapy. Since 2021 the patient has been receiving adjuvant aromatase inhibitor therapy in combination with zoledronic acid. A recent breast ultrasound and axillary ultrasound were performed today to assess the status of the aromatase inhibitor and zoledronic acid regimen, following routine laboratory evaluation. The current plan is to continue the aromatase inhibitor and zoledronic acid therapy as indicated.		
تحريراً في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	
	هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



الهيئة العامة للغذاء والدواء
تدريج القاهرة
مستشفى القاهرة

التاريخ: ٢٠٢٠/٨/١٦

المستشفى:

جهة العمل:

اسم المريض: ماجدة احمد السيد

رقم التأمين:

Axial CT chest, abdomen and pelvis with contrast was performed on multidetector CT unit:

Status follow up of known case of right lumpectomy

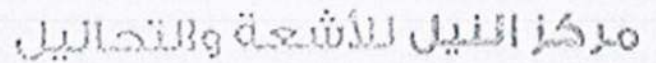
I-Chest

- The examined both lung fields show no alveolar, nodular or reticular interstitial densities. ✓
- No pleural or per-cardiac sac collection. ✓
- Normal appearance of heart and great vessels. ✓
- Intact bony thoracic cage. ✓

II-Abdomen & Pelvis

- The liver is average in size. No focal lesion or intra-hepatic biliary radical dilatation. ✓
- Patent portal vein. ✓
- The spleen appears average size and homogenous texture ✓
- No ascites or pelvic collection. ✓
- No significant lymphadenopathy ✓
- The examined rectum, sigmoid colon, both kidneys & urinary bladder are within normal. ✓
- Intact bony pelvis. ✓

Much Obligated,
Prof. Dr. Mostafa Morawe, MD



Date : 31/08/2020

Code No. : 11476815

تأمين صحي القاهرة - متنفعين Insurance Company

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History

- 54-year-old female patient presented with history of left breast cancer and referred for metastatic workup.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of 20 mCi of the tracer.

Findings

- No evidence of bone secondaries could be seen.
- Degenerative changes are noticed at different levels of the spine and around big joints.

IMPRESSION

- The skeleton is free from metastases.

Dr Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine